

УДК:616-089.5

И.Д.Илялетдинов, Б.Т.Мухамадиев, С.К.Жалгасбаев, М.Б.Муканова, Г.Б.Раев,
Н.З.Шапатов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение анальгетика Нефопам для послеоперационного обезболивания у онкологических пациентов

Аннотация. Статья посвящена первому опыту применения ненаркотического анальгетика Нефопам для послеоперационного обезболивания у онкологических пациентов в КазНИИОиР. Результаты показали перспективность его применения. Препарат показал эффективное обезболивание, значительно превосходящее слабый наркотический анальгетик трамадол.

Ключевые слова: применение, онкологические больные, анестезия, анальгетик Нефопам.

Проблема обезболивания в онкологии и онкохирургии является очень актуальной. Общеизвестно, что онкологические пациенты в терминальной стадии заболевания часто нуждаются в сильных наркотических анальгетиках (НА). В этой связи не следует злоупотреблять сильными НА при операциях средней травматичности, когда вполне достаточно обходится нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и ненаркотическими анальгетиками (ННА). В последние годы интерес представляет новый ННА Нефопам, под торговой маркой Акупан (Biocjdex, Франция) (1). Его обезболивающий механизм связан с ингибированием обратного захвата моноаминов на уровне синапсов. В настоящее время в арсенале средств для послеоперационного обезболивания в Республике Казахстан имеются в основном следующие препараты: сильный НА Промедол (Химфарм, Казахстан), слабый НА Трамадол (Химфарм, Казахстан), и различные варианты кеторолака или кетопрофена (Кетотоп, Кетанов и т.д.) в основном индийского или китайского производства.

Цель исследования

- провести сравнительную оценку эффективности послеоперационного обезболивания Нефопамом в сравнении с Трамадолом у пациентов, оперированных по поводу онкологических заболеваний.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено в отделении анестезиологии и реаниматологии (ОАРИТ) КазНИИОиР в 2010 году. В исследование вошло 13 пациентов, оперированных преимущественно по поводу онкологических заболеваний органов шеи, брюшной полости и женских половых органов. Больные были разделены на 2 группы, согласно таблице 1. Достоверных отличий по возрасту, полу, весу, характеру операций, расходу НА фентанила во время операции и продолжительности послеоперационной искусственной вентилляции легких (ИВЛ) между группами не было.

В основной группе Акупан применяли по следующей

Таблица 1 - Характеристика пациентов

	Основная группа (Акупан)	Контр. группа (Трамадол)
Количество пациентов (n)	7	6
Возраст (лет)	48±20	54±6
Вес (кг)	62±14	73±19
Рост (см)	162±8	168±6
Расход фентанила (мг)	0,74±0,5	0,46±0,16
Продолжительность послеоперационной ИВЛ (мин)	56±63	90±75

методике. Первые 20 мг Акупана вводили внутривенно капельным способом на 500 мл физиологического раствора в конце операции. В дальнейшем каждые 6 часов вводили Акупан по 20 мг внутримышечно, согласно инструкции по применению препарата (2).

В контрольной группе обезболивание проводили препаратом Трамадол (Химфарм, Казахстан) по 50-100 мг внутримышечно при наличии жалоб на боли.

При неэффективности данных схем послеоперационного обезболивания дополнительно назначали Промедол (Химфарм, Казахстан) по 20 мг внутримышечно. Потребность в препарате учитывали.

С целью оценки эффективности обезболивания исследовали простые гемодинамические показатели: систолическое артериальное давление (СистАД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частота сердечных сокращений (ЧСС), непосредственно перед введением препарата и через 2 часа после введения анальгетика. Характер жалоб и на боли определяли по упрощенной Визуально-аналоговой шкале по 5 балльной системе:

0 баллов - боли отсутствуют;

1 балл - незначительные боли, которые больной терпит;

2 балла - умеренные боли, требующие обезболивания;

3 балла - сильные боли;

4 балла - интенсивные нестерпимые боли.

Исследование проводили в течение 1 суток после операции. Регистрацию данных проводили на следующих этапах:

1. При поступлении пациентов в ОАРИТ

2. Через 6 часов

3. Через 12 часов

4. Через 18 часов

Статистическую обработку данных проводили в программе M1sgozop.Exce1 с использованием 1-критерия Стьюдента. Достоверность отличий принимали значимой при $p < 0,05$.

Таблица 2 - Гемодинамические изменения и интенсивность болей на этапах исследования в контрольной группе (трамадол)

	1 этап		2 этап		3 этап		4 этап	
	до	Через 2 часа	До	Через 2 часа	До	Через 2 часа	До	Через 2 часа
Систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.)	137±10	130±20	133±23	135±16	126±24	135±28	134±24	125±30
Диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст.)	81±14	81±16	85±17	87±13	78±15	77±21	82±22	73±13
Частота сердечных сокращений (уд/мин)	86±11	88±9	87±9	86±9	95 ± 13	101 ± 19	98±16	107±10
Интенсивность болей (балл)	2,8±0,4	2,3±0,8	2,5±0,8	2,3±0,8	1,8±1,1	1,8±0,4	2±1	1,6±0,5
Примечания: достоверных изменений в динамике не было								

Таблица 3 - Гемодинамические изменения на этапах исследования в основной группе (Акупан)

	1 этап		2 этап		3 этап		4 этап	
	до	Через 2 часа	До	Через 2 часа	До	Через 2 часа	До	Через 2 часа
Систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.)	119±30	110± 17	119±25	127±33	121±16	121±16	114±24	117±23
Диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст.)	72±13	71±11	72±7,5	71±10	76±10	76±8	68±8	68±5
Частота сердечных сокращений (уд/мин)	80±14	91 ±22	94±23	84±9	88±18	86±17	83±12	81±9*
Интенсивность болей (балл)	1,25±1,5	1,25±0,9	1,0±1,0*	0,6±0,5*	1,3±1,0	0,4±0,4*	1,2±0,4	0,6±0,51
Примечания: * - $p < 0,05$ в сравнении с контрольной группой 0 - $p < 0,05$ в сравнении с показателем перед введением анальгетика								

Результаты и обсуждение

Гемодинамические показатели в контрольной группе характеризовались стабильностью, уровни СистАД, ДАД, находились в пределах нормы, в соответствии с таблицей 2. Достоверных изменений СистАД и ДАД не было. ЧСС на 3 и 4 этапах исследования, то есть поздним вечером и ранним утром было умеренно повышенным, что может свидетельствовать о неадекватном уровне послеоперационного обезболивания. Через 2 часа после назначения дозы Трамадола тахикардия не только не уменьшалась, но и увеличивалась без достоверной разницы.

Уровень интенсивности болевых ощущений на 1 и 2 этапах был между 2 и 3 баллами, то есть требовалось назначение обезболивающих препаратов. При этом через 2 часа после назначения Трамадола, достоверного снижения интенсивности болевых ощущений не было.

Гемодинамические показатели в основной группе, также как и в контрольной характеризовались стабильностью, в соответствии с таблицей 3. Уровень СистАД был в пределах нормы, но все же несколько ниже, чем в контрольной группе, без достоверной разницы. Уровень ДАД также был в пределах нормы, и несколько ниже, чем в контрольной группе без достоверной разницы. ЧСС

было всегда в пределах нормы, в отличие от контрольной группы и на 3 и 4 этапах. На 4 этапе через 2 часа после введения анальгетика ЧСС было достоверно ниже, чем в контрольной группе. Это свидетельствует об адекватном послеоперационном обезболивании в основной группе.

Интенсивность послеоперационных болей находилась между 1 и 2 баллами, что говорит об отсутствии выраженного болевого синдрома. При этом на 2 и 3 этапах интенсивность болей было достоверно ниже, чем в контрольной группе, согласно таблице 3. На 4 этапе после назначения анальгетика интенсивность болей через 2 часа был достоверно ниже, чем до введения анальгетика.

Таким образом, несмотря на малое количество наблюдений и упрощенный дизайн исследования, предварительные данные позволяют судить об эффективности применения Акупана для послеоперационного обезболивания у онкологических пациентов. В контрольной группе, где применяли слабый наркотический анальгетик Трамадол, особого эффекта не было, поэтому приходилось применять в качестве дополнительного анальгетика Промедол по 20 мг в/м. В основной группе также имело место применение Промедола, но без достоверной разницы с контрольной группой. Каких-либо побочных эффектов при применении Акупана мы не отмечали.

Таблица 4 - Расход анальгетиков в группах

	Контрольная группа	Основная группа
Трамадол (мг)	250±54,8	-
Акупан (мг)	-	71,4±10,7
Промедол (мг)	23,3±19,7	31,4±25,4

Боль и послеоперационное обезбоживание в хирургии и в онкологии всегда будет оставаться серьезной проблемой. Наркотические анальгетики, несмотря на свою эффективность, не могут быть приемлемы ввиду синдрома привыкания и массы побочных эффектов. Рекомендуются проведение мультимодальной анальгезии с сочетанием НПВС и НА (3). ННА и НПВП в качестве альтернативы и дополнительного компонента представляют значительный интерес. В последние годы появилось много работ, показавших высокую эффективность Лорноксикама (Ксефокам, Никомед, Дания) (4). НПВП оказывают свой эффект за счет нарушения синтеза простагландинов и сочетают в себе противовоспалительный эффект.

Нефопам принципиально отличается от НПВП, поскольку оказывает центральное действие. Нефопам препарат нового поколения, и пока встречаются лишь единичные работы, исследующие его клиническую эффективность (1). Работ, посвященных сравнительной оценке лорноксиками и нефопамом пока не проводилось, что представляет интерес для дальнейших исследований. Данная работа является первым опытом применения препарата Акупан в КазНИИОнР. Методика введения Акупана соответствует концепции упреждающей анальгезии, когда лучше предупредить развитие болевого синдрома, чем ждать возникновения боли для назначения обезболивающих. Результаты данной работы указывают на необходимость рационализации послеоперационного обезбоживания у хирургических пациентов онкологического профиля, внедрению новых схем с использованием различных комбинаций НА, ННА и НПВП.

Выводы

1. Препарат Акупан является эффективным средством для послеоперационного обезбоживания у онкологических пациентов при операциях средней травматичности.
2. Препарат Акупан оказывает лучший анальгетический эффект, чем препарат Трамадол.

3. Оптимальным является сочетание наркотических и ненаркотических анальгетиков для обезбоживания в раннем послеоперационном периоде.

Список литературы

1. Черный В.И., Коваленко В.П. Акупан и спинальные анестезии // Медицина неотложных состояний. - 2011. - №7-8. - С. 38-39.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Акупан (нефопам), Биокодекс, Франция. Утверждена приказом №247 Председателя Комитета Фармацевтического контроля МЗ РК от 08.10.2008г.
3. Осипова Н.А. Алгоритм медикаментозного лечения острого болевого синдрома // СопэШит medicum. - 2006. - Т.8, № 5.
4. Петрова В.В., Осипова Н.А., Берегнев В.А. и соавт. Лорноксикам (ксефокам) как средство профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома среди других НПВП // Анестезиология и реаниматология. - 2005. - №5.

Тұжырым

И.Д.Илялетдинов, Б.Т.Мухамадиев, С.К.Жалгасбаев, М.Б.Муканова, Г.Б.Раев, Н.З.Шапатова

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Онкологиялық науқастарды отадан кейінгі жансыздандыруға қолданылатын анальгетик Нефопам. Мақала наркотикалық емес анальгетик Нефопамды алғаш рет ҚазОЖРҒЗИ онкологиялық науқастарда қолдану тәжірибесіне арналған. Нәтижелер оның қолдану тиімділігін көрсетті. Дәрілік зат ауру сезімінің жақсы басып, әлсіз наркотикалық анальгетик трамадолдан күні әсер көрсетті.

Түйінді сөздер: ота, онкологиялық аурулар, жансыздандыру, анальгетик Нефопам

Summary

I.D. Ilyaletdinov, B.T.Muhamadiev, S.K.Zhargasbay, M.B.Mukanova, G.B.Rayev, N.Z.Shapatova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Analgesic nefopam for postoperative pain relief in cancer patients

This article describes the first experience of non-narcotic analgesic Nefopam for post-operative analgesia in oncologic patients of KSRIOR. The evidence showed perspective for it. Nefopam showed effective pain control, which was higher, than with wear narcotic tramadol.

Keywords: surgery, cancer, anesthetic, analgesic nefopam.